Del protocolo a la exclusión: brechas estructurales en el acceso al aborto terapéutico en Perú

Resumen

El aborto terapéutico es legal en el Perú desde 1924, pero su acceso sigue obstaculizado por una compleja red de barreras normativas, institucionales y sociales. Este estudio analiza la implementación del servicio en el Hospital Regional de Cajamarca a partir de seis historias clínicas, entrevistas con profesionales de salud y derecho, análisis de protocolos y una etnografía con una usuaria de zona rural. Los hallazgos revelan una desconexión entre la normativa legal y su aplicación práctica, marcada por la discrecionalidad médica, exigencias extralegales, dilaciones injustificadas y ausencia de seguimiento post-aborto. Además, se identifican desigualdades interseccionales que afectan especialmente a mujeres y personas gestantes rurales, adolescentes o con condiciones de vulnerabilidad. La investigación propone incorporar enfoques de justicia reproductiva y diseño centrado en las usuarias para transformar el servicio en un derecho garantizado, y no en una excepción improbable.

Palabras clave: *aborto terapéutico, derechos sexuales y reproductivos, diseño centrado en la usuaria, salud pública.*

Abstract

Therapeutic abortion has been legal in Peru since 1924, yet access remains obstructed by a complex network of regulatory, institutional, and social barriers. This study analyzes the implementation of the service at the Regional Hospital of Cajamarca, based on six medical records, interviews with healthcare and legal professionals, protocol reviews, and ethnographic observation with a rural user. The findings reveal a disconnect between legal norms and their practical application, characterized by medical discretion, extra-legal requirements, unjustified delays, and lack of post-abortion follow-up. The study also identifies intersectional inequalities that disproportionately affect rural women, adolescents, and pregnant people in vulnerable conditions. The research advocates for the integration of reproductive justice and user-centered design approaches to ensure that therapeutic abortion is treated as a guaranteed right, rather than an improbable exception.

Keywords: *public health, sexual and reproductive rights, therapeutic abortion, user-centered design*

1. Introducción

El aborto terapéutico es legal en Perú desde 1924 y cuenta con una **Guía Técnica Nacional** para su aplicación desde 2014. Sin embargo, a pesar de su reconocimiento normativo, su acceso sigue estando condicionado por barreras institucionales, sociales y médicas que dificultan su implementación efectiva. En muchos casos, las usuarias que requieren este procedimiento enfrentan retrasos, obstáculos burocráticos y decisiones arbitrarias del personal de salud, lo que genera un impacto directo en su bienestar y, en algunos casos, pone en riesgo su vida.

Si bien el Perú ha avanzado en la regulación del aborto terapéutico mediante normativas específicas, la criminalización del aborto en general sigue afectando el acceso a este derecho. Entre 2016 y 2022, **64 personas fueron denunciadas penalmente** por realizarse un aborto terapéutico (SIDPOL PNP, 2023), pese a que, según la normativa vigente, no deberían ser objeto de persecución legal. Asimismo, las estadísticas de salud pública evidencian que, en promedio, **el 29.5% de las muertes maternas en el país están relacionadas con enfermedades preexistentes** (Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, 2025). Tan solo en el año 2023, la cantidad de muertes maternas indirectas ascendió a 97 usuarias, quienes fallecieron a pesar de tener un protocolo estandarizado desde hace 9 años (Minsa, 2025).

El **Hospital Regional Docente de Cajamarca**, uno de los pocos establecimientos de salud que ha implementado su propio protocolo institucional para el aborto terapéutico, ha registrado solo **seis solicitudes entre 2019 y 2023**. De estas, cinco fueron aprobadas y una fue rechazada por superar el límite gestacional de 22 semanas. Los casos atendidos en este hospital incluyen diagnósticos médicos graves, como **lupus eritematoso sistémico, carcinoma metastásico y malformaciones fetales**, lo que refleja la urgencia de contar con un servicio accesible y eficiente para personas en condiciones de alto riesgo.

Este estudio busca comprender **cómo funciona realmente el servicio de aborto terapéutico en el Perú y cuáles son las brechas que impiden su acceso efectivo**. Para ello, se ha tomado como referencia el caso de **Fernanda**, una adolescente de 14 años que logró acceder al servicio en su región, en contraste con otras experiencias donde el acceso es denegado sistemáticamente. A través del análisis de casos atendidos en el Hospital Regional de Cajamarca, entrevistas con especialistas en salud y derecho, y la reconstrucción del recorrido de las usuarias dentro del sistema de salud, esta investigación aporta una visión

integral sobre los factores que facilitan o restringen el acceso al aborto terapéutico en el país.

2. Marco conceptual

2.1. Poder, cuerpos y salud: la biopolítica como marco de análisis

El acceso al aborto terapéutico en el sistema público de salud debe ser comprendido desde una lógica biopolítica, en la que el Estado regula la vida no solo a través de leyes, sino mediante intervenciones directas sobre los cuerpos. Foucault (1999) advierte que el control social opera sobre los cuerpos y con los cuerpos: la medicina se convierte en una estrategia de poder, y el cuerpo, en una realidad biopolítica. En este sentido, los sistemas de salud pública no son neutros, sino espacios de gobernabilidad donde se decide quién merece vivir y bajo qué condiciones (Quintanas, 2011).

Aplicado al aborto terapéutico, esto se traduce en regulaciones que subordinan la autonomía de las mujeres y personas gestantes a criterios médicos, jurídicos y morales. Carol Arcos (2018) amplía esta idea con el concepto de *biopolítica de lo materno*, según el cual el Estado no solo regula la reproducción, sino que convierte la capacidad de gestar en un interés nacional. Así, el cuerpo gestante no es un sujeto de derechos, sino un dispositivo de reproducción simbólica y material del Estado-nación.

Esta lógica se reproduce en las instituciones de salud, donde el aborto terapéutico, pese a estar legalizado desde 1924, sigue siendo regulado como una excepción médica y no como un derecho garantizado. Las políticas públicas que norman el procedimiento reflejan esa tensión: el cuerpo se convierte en campo de disputa entre el control institucional y la autonomía reproductiva.

2.2. Discrecionalidad, burocracia y desigualdad en el acceso

En la práctica cotidiana, el personal médico actúa como “burócrata de calle”, en el sentido propuesto por Lipsky (citado en Chang y Brewer, 2023): profesionales que tienen poder discrecional para aplicar o no las políticas públicas. Esta discrecionalidad se manifiesta en la interpretación de causales, en los tiempos de respuesta, en los requisitos exigidos y en la calidad de la atención. Aunque, en contextos excepcionales como la pandemia, esta facultad ha sido vista como una herramienta para garantizar el derecho a la salud (Chiliquinga y Erazo, 2023), en el caso del aborto terapéutico se convierte en una barrera. Bielsa y Lozano (citados

en Chiliquinga y Erazo, 2023) explican que, en ausencia de reglas precisas, las decisiones se basan en juicios subjetivos.

Esta discrecionalidad también se vincula con los miedos del personal de salud a ser investigado o sancionado, lo que genera demoras deliberadas o decisiones restrictivas. Así, el acceso a un derecho termina dependiendo de la voluntad del profesional asignado, creando una desigualdad estructural entre quienes acceden a la atención médica según su lugar de residencia, su edad, o el criterio del médico tratante.

Estas desigualdades se profundizan cuando se aplican sin una mirada interseccional. La evidencia muestra que ciertos grupos —adolescentes, mujeres rurales, personas con discapacidad o de bajos recursos— enfrentan múltiples capas de exclusión. La vulnerabilidad, como señala Granados (2022), es un estado multidimensional determinado por factores estructurales, comunitarios e individuales. En este contexto, los sesgos interseccionales operan cuando el personal médico interpreta síntomas o define tratamientos influido por estereotipos, lo que puede resultar en diagnósticos errados o atención deficiente (Amaya, Jiménez y Bermúdez, 2023).

2.3. Justicia reproductiva y la lógica de exclusión

El marco de la justicia reproductiva, desarrollado por Ross y Solinger (2017), permite situar el aborto más allá del plano legal, en un contexto de derechos humanos, autonomía corporal y justicia social. Este enfoque evidencia cómo las barreras que enfrentan las personas gestantes no son individuales ni accidentales, sino parte de un sistema diseñado para excluir a quienes están en situaciones de mayor vulnerabilidad.

Oliveira y Martínez (2022) critican cómo el sistema biomédico dominante patologiza los cuerpos femeninos y silencia su agencia. Esta lógica institucional reproduce prácticas de violencia gineco-obstétrica (VGO), entendida como una forma de violencia de género estructural que se manifiesta particularmente en hospitales públicos (Sesia, 2020). Negar información, imponer requisitos arbitrarios o desestimar el testimonio de las usuarias son expresiones de esta violencia, que a menudo pasa inadvertida por estar institucionalizada.

Una manifestación clave de esta exclusión estructural es la inversión del principio de garantía. En lugar de asumir que el aborto terapéutico debe ser garantizado por el Estado como parte del derecho a la salud, se exige a las personas gestantes que demuestren el riesgo para su vida o salud (Sridhar et al., 2024). Esta lógica de “carga de la prueba” constituye una barrera que refuerza la judicialización de la experiencia reproductiva. Bergallo (2018) advierte que, incluso en contextos donde el aborto es legal por causales, persiste el

riesgo de criminalización y la inhibición del servicio. Halland et al. (2020) refuerzan esta idea, señalando que la existencia de normativas no garantiza el acceso efectivo, especialmente en sistemas jerarquizados, estigmatizantes y desarticulados.

En el caso peruano, la Guía Técnica Nacional de 2014 no ha sido suficiente para asegurar la atención oportuna ni la información adecuada (Ramírez, 2022). Así, el sistema funciona como un dispositivo de exclusión progresiva: mientras más vulnerable es la persona, más difícil se vuelve ejercer el derecho al aborto terapéutico.

2.4. Rediseñar el sistema desde la experiencia de las usuarias

Ante este escenario, el diseño centrado en la usuaria (*user centered design*, UCD) se presenta como un enfoque prometedor para transformar los servicios de salud. A diferencia del modelo biomédico tradicional, que prioriza la eficiencia institucional, el UCD propone diseñar soluciones adaptadas a las realidades, necesidades y trayectorias de las personas usuarias (Melles et al., 2020).

En salud pública, este enfoque permite superar la brecha entre las intervenciones basadas en evidencia y su aplicabilidad en contextos reales. Como señalan Dopp et al. (2020), muchas prácticas clínicas fracasan al trasladarse a territorios donde no fueron diseñadas. El UCD plantea una lógica iterativa y participativa que articula lo micro, meso y macro de los sistemas de cuidado.

En el caso del aborto terapéutico, adoptar este enfoque implica rediseñar los servicios a partir de las trayectorias reales de las usuarias, reconociendo que las barreras burocráticas, la fragmentación institucional y los sesgos estructurales afectan de manera diferencial a las personas. Como afirman Erwin y Krishnan (2016), los sistemas de atención deben ajustarse a las personas, no al revés. Incorporar esta mirada exige voluntad política, formación interdisciplinaria y una reconfiguración profunda del modelo de atención, con el objetivo de garantizar el acceso real y digno al aborto terapéutico como parte del derecho a la salud.

3. Metodología

Este estudio se desarrolló bajo un enfoque cualitativo y transdisciplinario, integrando métodos etnográficos, análisis documental y entrevistas en profundidad para comprender la implementación del aborto terapéutico en el Hospital Regional de Cajamarca. La investigación tuvo como objetivo identificar las barreras sistémicas que enfrentan las usuarias, los puntos críticos en la prestación del servicio y los factores estructurales que condicionan el acceso a este derecho.

Revisión bibliográfica y análisis legal

Se llevó a cabo una revisión exhaustiva de literatura científica, normativas nacionales e internacionales y protocolos de atención en salud vinculados al aborto terapéutico, abordando su análisis desde tres perspectivas clave: médica, social y legal.

Desde una perspectiva médica, se examinó la regulación del aborto terapéutico en el Perú en relación con estándares internacionales, analizando la Guía Técnica Nacional para la Estandarización del Procedimiento de Aborto Terapéutico y su correspondencia con protocolos de organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO).

Desde un enfoque social, se revisaron investigaciones previas sobre barreras en el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva en América Latina, con especial énfasis en estudios sobre la criminalización del aborto y su impacto en la atención médica y salud de las pacientes.

Finalmente, desde una perspectiva legal, se compararon las disposiciones del Código Penal Peruano, la Guía Técnica Nacional y el protocolo del Hospital Regional de Cajamarca, identificando posibles restricciones adicionales impuestas a nivel hospitalario. Se analizaron disposiciones como la exigencia de testigos, la participación de dos psiquiatras en casos de salud mental y los tiempos de espera para la Junta Médica, evaluando su alineación con la normativa nacional e internacional.

Análisis de historias clínicas

Mediante acceso a la información pública, se recopilaron y analizaron seis historias clínicas de usuarias atendidas en el Hospital Regional Docente de Cajamarca. Este análisis permitió identificar patrones en la atención, tiempos de espera, actores involucrados y obstáculos recurrentes en la implementación del aborto terapéutico. La información fue sistematizada

en la herramienta colaborativa Miro, facilitando su visualización y permitiendo un análisis comparativo en sesiones colectivas del equipo de investigación.

Entrevistas a especialistas en Cajamarca y Lima

Se realizaron entrevistas en profundidad con actores clave en salud, derecho y sociedad civil para comprender los desafíos en la implementación del aborto terapéutico.

En Lima, se entrevistó a: un gineco-obstetra del Instituto Nacional Materno Perinatal y una abogada de Proyecta Igualdad, especialista en la defensa de derechos reproductivos.

En Cajamarca, se entrevistó a: 3 tres médicos gineco-obstetras del Hospital Regional, el jefe del servicio de ginecología del hospital, y 1 abogada que patrocinó a una adolescente que accedió a aborto terapéutico.

Las entrevistas se enfocaron en la aplicación de la Guía Técnica Nacional, la percepción del personal médico sobre el aborto terapéutico, los retos en la ejecución del servicio y las experiencias de litigio estratégico en casos similares.

Etnografía

Se incorporó una estrategia etnográfica para capturar el recorrido real de una usuaria del servicio. Se visitó el caserío **Casa Blanca, en José Sabogal, San Marcos**, para entrevistar a la usuaria del caso de estudio y su familia, obteniendo información clave sobre las condiciones socioeconómicas, geográficas y culturales que influyen en el acceso al aborto terapéutico. Se reconstruyó su experiencia a través de entrevistas a profundidad, permitiendo mapear el trayecto desde su primer contacto con el sistema de salud hasta la resolución del caso.

Sistematización y análisis de información

Toda la información recolectada—incluidas notas de entrevistas, datos de campo, historias clínicas y análisis normativo—fue organizada en matrices temáticas y sistematizada en Miro. Se llevó a cabo una sesión colectiva de clusterización de hallazgos, lo que permitió priorizar los puntos críticos del acceso al aborto terapéutico en Cajamarca. Este proceso facilitó la identificación de patrones y brechas en el servicio, asegurando que los hallazgos del estudio se fundamenten en evidencia empírica robusta y permitan el desarrollo de recomendaciones basadas en datos.

Journey as is: Del modelo ideal al modelo real

Se diseñaron dos journey maps para analizar la experiencia de las usuarias desde dos perspectivas:

Journey to Be (Modelo ideal): Basado en la Guía Técnica Nacional para la Estandarización del Procedimiento de Aborto Terapéutico y en el protocolo del Hospital Regional de Cajamarca, estableciendo el proceso teórico que debería seguirse en un contexto normativo óptimo.

Journey As Is (Modelo real): Reconstrucción del recorrido real de las usuarias, desde el primer contacto con el sistema de salud hasta la resolución del caso, evidenciando brechas y puntos críticos en la atención.

Estos mapas permitieron visualizar las discrepancias entre la normativa y su implementación práctica, así como identificar las decisiones, demoras y barreras administrativas que afectan el acceso a este derecho. Los journey maps están disponibles en Miro para consulta y análisis.

4. Hallazgos

4.1. De la norma a la barrera: Cómo el acceso al aborto terapéutico se vuelve más difícil con cada regulación

El Código Penal peruano establece de manera clara y directa que "No es punible el aborto terapéutico si es practicado por un médico". No menciona plazos, requisitos adicionales ni condiciones específicas. En su formulación más básica, el acceso al aborto terapéutico no debería estar sujeto a barreras burocráticas adicionales. Sin embargo, conforme la norma se ha ido traduciendo en regulaciones y protocolos institucionales, se han generado nuevas exigencias que terminan dificultando el acceso a este derecho.

<u>De la norma general a la regulación restrictiva</u>

Cuando se aprueba la Guía Nacional para la Aplicación del Aborto Terapéutico (2014), se incorporan restricciones que no estaban en la norma penal original:

- Solo se regula hasta la semana 22 de gestación.
- Se requiere la evaluación de una Junta Médica, lo que añade tiempo y procesos adicionales.
- Se exige la participación de al menos un médico especializado en la patología de base.
- El procedimiento solo puede realizarse en un hospital de Nivel II, lo que excluye a establecimientos de salud de menor nivel y restringe el acceso en zonas rurales.

Cada una de estas condiciones introduce demoras y complejidades innecesarias, alejando el acceso real de la población que lo necesita.

<u>El caso concreto: el Protocolo del Hospital Regional de Cajamarca</u>

Al aterrizar aún más la regulación a nivel hospitalario, encontramos que las barreras aumentan hasta llegar a requisitos absurdos que complican el proceso sin justificación médica:

- Si la usuaria rechaza el procedimiento recomendado por el médico, se llama a la fiscalía de prevención del delito, a través de la Policía Nacional, para levantar un acta. Esto representa una medida coercitiva innecesaria, pues genera un clima de vigilancia sobre las pacientes y vulnera su derecho a la autonomía.
- Para los casos de salud mental, se exige la evaluación de dos psiquiatras. Esta medida, que no está contemplada en la Guía Nacional, añade una exigencia

desproporcionada que en la práctica dilata más el acceso al procedimiento. Sumado a ello, los hospitales en provincia carecen de psiquiatras. En toda la región Cajamarca, solo hay dos psiquiatras, de los cuales ninguno labora en el Hospital Regional Docente de Cajamarca. Las cifras son similares para el resto de regiones, en promedio cuentan con 1 psiquiatra (Minsa, 2024).

- El protocolo sugiere, en la práctica se exige, la presencia de la pareja o un familiar como testigo para la firma de consentimiento, algo que no se solicita para otros procedimientos médicos de similar magnitud. Esta condición refuerza la tutela sobre la decisión de la persona gestante, vulnerando su autonomía.

El análisis de estos niveles de regulación muestra cómo el aborto terapéutico, que en su origen es un derecho garantizado sin restricciones en el Código Penal, se convierte en una ruta llena de barreras con cada nivel de reglamentación adicional.

Desde la norma penal hasta la regulación hospitalaria, se construyen condiciones que lejos de facilitar el acceso al procedimiento, lo vuelven cada vez más inaccesible. En la práctica, esto significa que muchas mujeres y personas gestantes ven negado su derecho, no por falta de base legal, sino por la existencia de un sistema que, en su intento de regular, termina funcionando como un mecanismo de exclusión.

4.2. Barreras adicionales impuestas en el proceso: La firma de un "testigo"

Uno de los obstáculos más significativos identificados en el acceso al aborto terapéutico es la exigencia de la firma de un "testigo", generalmente la pareja o la madre de la usuaria. Este requisito, que no está contemplado en la normativa vigente, se ha convertido en una práctica extendida en hospitales como el Regional de Cajamarca.

De los seis casos analizados en este estudio, tres correspondían a mujeres mayores de 18 años (21, 24 y 26 años). En todos estos casos, los documentos clave del proceso —como la solicitud de aborto terapéutico y el consentimiento informado— incluían la firma de un tercero, ya sea un familiar o una pareja.

Uno de los casos más ilustrativos es el de una mujer de 21 años, proveniente del caserío Aylambo (Jesús), quien llegó al hospital con un dolor lumbar severo que la había incapacitado progresivamente durante un año. Al momento de la consulta, tenía 13 semanas de gestación. Luego de 15 días en el hospital, se le diagnosticó un tumor retroperitoneal y la Junta Médica determinó que debía acceder a un aborto terapéutico. Sin embargo, en la hoja de decisión no solo aparece su firma, sino también la de su madre, a pesar de ser mayor de edad y haber brindado su consentimiento de forma independiente.

4.3. Dilación deliberada en la toma de decisiones médicas

Uno de los hallazgos más preocupantes en el estudio es la dilación deliberada en la convocatoria de la Junta Médica para la autorización del aborto terapéutico, incluso en casos de alto riesgo para la salud y la vida de la gestante. Esta demora no solo prolonga el sufrimiento de las usuarias, sino que también agrava su estado de salud y, en algunos casos, pone en peligro su vida.

El caso de una mujer de 24 años del centro poblado de San Juan de Lacamaca (Bambamarca) ilustra esta problemática. La usuaria presentaba una condición médica extremadamente delicada: lupus eritematoso sistémico (LES) activo, hipertensión arterial crónica (HTA) y antecedentes de derrames pleural y pericárdico. A las 17 semanas de gestación, se le diagnosticó un retardo severo en el crecimiento fetal, lo que indicaba un alto riesgo tanto para ella como para el feto.

Inicialmente, la paciente ingresó al área de nefrología, donde su caso fue identificado como de alta complejidad y se sugirió la convocatoria de una Junta Médica. Sin embargo, esta solicitud no se atendió de inmediato. Pasaron tres semanas antes de que finalmente se convocara una Junta Médica de emergencia, a pesar del evidente deterioro de la salud de la paciente y el riesgo inminente que enfrentaba.

La reticencia del personal médico a tomar decisiones oportunas en estos casos no es casual. Según el testimonio del jefe de la Dirección de Gineco-Obstetricia, la principal razón detrás de esta demora es el temor a ser investigados o sancionados:

> *"Los gineco-obstetras somos más propensos a que nos auditen o nos investiguen, más que otras especialidades. Todos tenemos que pagar abogados cada vez que se investiga un caso. Por eso los colegas no se quieren meter en casos de aborto por cuestiones legales."*

Este temor, sumado a la falta de claridad en la normativa y al estigma en torno al aborto terapéutico, crea un ambiente de incertidumbre en el personal de salud, lo que se traduce en demoras evitables en la toma de decisiones críticas. En la práctica, esto implica que, aunque el aborto terapéutico está legalmente permitido en el Perú, su acceso sigue dependiendo de factores ajenos a criterios estrictamente médicos, exponiendo a las usuarias a riesgos innecesarios y vulnerando su derecho a recibir atención oportuna y adecuada.

4.4. Falta de seguimiento post-aborto debido a la desarticulación del sistema de salud

Otro problema crítico identificado en el estudio es la ausencia de seguimiento post-aborto terapéutico, especialmente en usuarias provenientes de zonas rurales. La desarticulación entre los establecimientos de salud de Nivel II y Nivel I, sumada a las dificultades geográficas, genera que muchas pacientes sean dadas de alta sin un plan de monitoreo claro ni mecanismos efectivos para garantizar su recuperación.

El caso de una adolescente de 16 años con discapacidad intelectual, víctima de violencia sexual y proveniente del caserío San Juan (Matará), evidencia esta falencia estructural. A las 6 semanas de gestación, la paciente fue sometida a un aborto terapéutico. Sin embargo, no respondió a la primera dosis de misoprostol, lo que requirió la realización de un procedimiento de Aspiración Manual Endouterina (AMEU) debido a la falta de expulsión. Durante el procedimiento, la paciente presentó hipertensión alta, una complicación que demandaba un monitoreo cuidadoso. A pesar de esto, fue dada de alta al día siguiente sin que se registrara un seguimiento adecuado en su centro de salud local.

Este tipo de situaciones reflejan la brecha existente en la articulación del sistema de salud para garantizar el cuidado continuo de las usuarias. Un médico gineco-obstetra del Hospital Regional describe la lógica actual de derivación post-aborto:

> *"Si la paciente es de la ciudad de Cajamarca, lo ideal es que vaya a consultorio externo. Si no es de aquí, hace sus controles en su centro de salud más cercano."*

Sin embargo, esta estrategia no garantiza un seguimiento efectivo, ya que en muchos centros de salud rurales no se cuenta con el personal capacitado o los recursos para dar continuidad a la atención. Aunque existen esfuerzos para mejorar esta coordinación, como lo menciona otro especialista:

> *"En Cajamarca se ha aplicado la estrategia de tener un personal profesional obstetra que se encarga de coordinar e informar sobre el seguimiento de los pacientes de periferia. Pero la verdad es que no nos damos abasto."*

Este testimonio confirma que, en la práctica, la estrategia de seguimiento resulta insuficiente para cubrir la demanda de usuarias que requieren atención post-aborto. La falta de monitoreo aumenta el riesgo de complicaciones no tratadas, impacto emocional no abordado y una mayor vulnerabilidad para aquellas mujeres que, como en el caso descrito, enfrentan múltiples situaciones de riesgo.

Garantizar un sistema de seguimiento efectivo es crucial para que el aborto terapéutico no solo sea un procedimiento clínico aislado, sino una intervención integral que priorice la recuperación y el bienestar de las usuarias. Esto implica fortalecer la articulación entre niveles de atención, asignar personal exclusivo para el seguimiento de pacientes en zonas rurales y establecer mecanismos claros para que las usuarias puedan acceder a controles posteriores sin trabas geográficas o administrativas.

4.5. Brecha en la identificación del riesgo de manera integral y oportuna

Uno de los problemas más críticos en el acceso al aborto terapéutico es la falta de identificación temprana del riesgo para la salud de la gestante. La fragmentación en la atención entre el primer y segundo nivel de salud, sumada a la escasa socialización del protocolo de aborto terapéutico y la falta de garantías legales para el personal médico, impide una respuesta oportuna.

El caso de una mujer de 26 años, proveniente de Tacabamba (Chota), con diagnóstico de lupus eritematoso sistémico (LES) y antecedentes de cinco embarazos previos, ilustra esta problemática. La paciente ingresó al hospital con 17 semanas de gestación y fue evaluada por la Junta Médica, que determinó que se requerían más exámenes antes de emitir un dictamen, programando una nueva evaluación en 24 horas. Durante ese período, se le suspendieron dos medicamentos esenciales para el control de su enfermedad.

Sin embargo, la Junta Médica no volvió a reunirse en el tiempo indicado y la evaluación se postergó cinco días, retraso en el que la paciente permaneció sin tratamiento. Finalmente, cuando la Junta aprobó el aborto terapéutico, este se realizó el mismo día, pero el daño en su salud ya era irreversible. Dos meses después, la paciente falleció debido a complicaciones derivadas del LES, dejando en evidencia las graves fallas en la identificación temprana del riesgo y la demora en la toma de decisiones médicas.

La falta de preparación del personal de salud en establecimientos periféricos es un factor clave en esta problemática, como señala un médico gineco-obstetra del Hospital Regional:

> *"La mayoría del personal de salud de periferia no conoce este procedimiento y pienso que no identifica bien el riesgo para poder solicitarlo o referirlo al menos para una evaluación. No tienen las herramientas y aquí llegan en las últimas."*

Este testimonio revela que muchas gestantes con condiciones de alto riesgo no son detectadas a tiempo en los centros de salud de primer nivel, lo que impide que sean referidas oportunamente para una evaluación especializada. Al llegar a hospitales de mayor

complejidad, la progresión de su condición de salud ya es severa, y las decisiones médicas se toman en situaciones límite.

Además, la falta de socialización del protocolo de aborto terapéutico genera incertidumbre en los equipos médicos, que pueden percibir riesgos legales al autorizar el procedimiento. La ausencia de garantías para proteger al personal de salud ante eventuales denuncias o represalias contribuye a la postergación deliberada de la decisión, lo que pone en peligro la vida de las pacientes.

Para cerrar esta brecha, es urgente implementar estrategias que fortalezcan la identificación del riesgo desde el primer nivel de atención. Esto implica capacitar al personal de salud en la detección de casos que requieren derivación, mejorar la articulación con los hospitales de referencia y garantizar condiciones seguras para que los profesionales de la salud puedan aplicar el protocolo sin temor a consecuencias legales. Sin estos cambios, las demoras seguirán costando vidas que pudieron haberse salvado con una intervención oportuna.

4.6. Acceso improbable: el caso de Fernanda

En el sistema de salud peruano, si el riesgo para la salud de la persona gestante no es identificado, el servicio de aborto terapéutico simplemente no se activa. Esto significa que, para la mayoría de mujeres y personas gestantes en situación de riesgo, la posibilidad de acceder a este derecho ni siquiera existe oficialmente. Solo un número muy reducido de usuarias logra atravesar todas las barreras del sistema y acceder al procedimiento.

El caso de Fernanda, una adolescente de 14 años de una zona rural de Cajamarca, ejemplifica lo excepcional que es el acceso real al aborto terapéutico. Su historia no solo es un testimonio de la lucha individual y familiar por ejercer un derecho, sino una muestra clara de que el sistema de salud no garantiza el acceso de manera efectiva. Su caso fue posible gracias a una serie de factores que rara vez coinciden en otros casos:

- Un equipo médico que no bloqueó su solicitud.
- Apoyo familiar constante y decidido.
- Intervención de la sociedad civil y presión mediática.

Su historia contrasta con la de muchas otras adolescentes y mujeres que enfrentan las mismas circunstancias pero que son rechazadas en hospitales regionales. En la mayoría de

los casos, quienes buscan acceder a este derecho terminan viéndose obligadas a viajar a Lima, asumiendo costos inalcanzables y atravesando un proceso aún más desgastante.

Un camino de 110 km para acceder a un derecho

Fernanda y su padre iniciaron un trayecto de más de 110 km desde su comunidad rural hasta el Hospital Regional de Cajamarca. El viaje implicó:

- 1 hora caminando desde su hogar hasta la carretera más cercana.
- 5 horas en bus hasta la ciudad de Cajamarca.
- Un gasto aproximado de 90 USD en una semana, lo que representó el 80% del ingreso mensual de su familia.

Para muchas familias en situación de vulnerabilidad, estos costos son prohibitivos, lo que convierte el acceso al aborto terapéutico en un privilegio prácticamente inaccesible.

Un sistema que no garantiza, sino que depende de factores externos

El acceso de Fernanda no se debió a la garantía de un sistema de salud funcional, sino a la suma de factores poco probables:

1. La familia que la apoyó

> *"Siempre la apoyamos, no queríamos que Fernanda deje el colegio, como nosotros."* - Mamá de Fernanda.

Sus padres le creyeron, denunciaron a los agresores y respaldaron su decisión de interrumpir el embarazo tras verla afectada. Incluso resistieron amenazas de autoridades locales y presiones de familiares que los juzgaban por su decisión.

2. Una profesional de salud informada

> *"La obstetriz de la posta vino y nos dijo que se podía pedir un aborto terapéutico."* – Papá de Fernanda.

En el primer nivel de atención, una obstetra empática e informada les orientó y mencionó que ya había habido un caso similar tratado en el Hospital Regional de Cajamarca, lo que generó confianza en la familia.

3. Presión mediática como garantía de acceso

> *"Fui a los medios porque nos estaban amenazando y maltratando a mi hija."* – Papá de Fernanda.

La decisión del padre de exponer el caso en medios locales y nacionales fue determinante. La cobertura mediática permitió que la sociedad civil presionara a los operadores de justicia y de salud para que el caso fuera tratado con seriedad. Además, logró que se activaran redes de apoyo que de otra manera no habrían intervenido.

4. Una abogada que facilitó el acceso

> *"La señorita abogada nos ayudó mucho, ella se encargó de todo."* – Papá de Fernanda.

El acompañamiento legal brindado por Proyecta Igualdad fue clave para que la familia pudiera navegar el sistema de salud, completar los trámites burocráticos y gestionar su caso ante la fiscalía y los medios de comunicación. La abogada, además, conocía al personal administrativo del hospital, lo que facilitó el proceso.

Una improbabilidad estadística

Que Fernanda haya logrado acceder al aborto terapéutico fue el resultado de una serie de condiciones excepcionales que rara vez se alinean en un solo caso. Esto deja en evidencia que el sistema de salud no garantiza realmente este derecho, sino que las personas deben depender de redes de apoyo informales, profesionales de salud con voluntad de acción y exposición mediática para lograr lo que debería ser un acceso asegurado.

Sin cambios estructurales en la identificación de riesgo, la articulación entre niveles de atención y la eliminación de barreras burocráticas, el acceso al aborto terapéutico seguirá siendo una excepción y no una realidad para la mayoría de las personas que lo necesitan.

5. Discusión

Los hallazgos de este estudio revelan que, en el Perú, el acceso al aborto terapéutico —aunque legal desde 1924— se ve sistemáticamente restringido por múltiples capas de regulación, prácticas institucionales discrecionales y una lógica probatoria que convierte un derecho en una ruta de obstáculos. Esta realidad no solo contradice el mandato legal establecido en el código penal, sino que también pone en evidencia el carácter biopolítico del sistema de salud, tal como lo plantea Foucault (1999). En este caso, la multiplicación de barreras reglamentarias —desde la Guía Nacional hasta protocolos hospitalarios— refleja cómo el poder biopolítico se materializa en formas burocráticas que limitan el acceso a derechos sexuales y reproductivos.

El análisis de los protocolos y su implementación en hospitales como el Regional de Cajamarca muestra que las regulaciones institucionales operan como mecanismos de exclusión progresiva. A medida que se desciende del nivel normativo al operativo, se acumulan condiciones que restringen el acceso efectivo. Esta progresiva institucionalización de barreras confirma la tesis de Arcos (2018) sobre la biopolítica de lo materno: el Estado no solo interviene en los cuerpos, sino que asume la capacidad de gestar como un bien colectivo, supeditado a criterios de utilidad y gobernabilidad.

En este contexto, la discrecionalidad médica emerge como un factor central en la implementación desigual del aborto terapéutico. Tal como advierte Lipsky, los profesionales de salud actúan como "burócratas de calle" que interpretan la norma en el punto de contacto con la ciudadanía. Nuestros hallazgos evidencian cómo esta discrecionalidad se ejerce no solo en función de criterios clínicos, sino también a partir de miedos, estigmas y convicciones personales. La dilación deliberada de Juntas Médicas, la exigencia de requisitos extralegales —como la firma de un testigo o evaluaciones psiquiátricas adicionales— y el temor a sanciones legales por parte del personal médico, configuran una práctica en la que el juicio subjetivo y la ausencia de garantías institucionales terminan vulnerando derechos fundamentales. Esta realidad subraya la importancia de establecer mecanismos efectivos de supervisión y estándares claros que reduzcan el margen de interpretación subjetiva, garantizando que el acceso al aborto terapéutico no dependa del profesional asignado, sino de criterios objetivos y uniformes alineados con los derechos reconocidos.

Por otro lado, esta misma capacidad de flexibilización podría aplicarse para eliminar barreras innecesarias y garantizar el acceso oportuno a este servicio. En este sentido, si bien es clave

tener un protocolo claro, también lo es sensibilizar al personal médico para su uso. De modo que, cuando les corresponda usar su margen de discrecionalidad, lo hagan con principios de humanidad y centrado en las usuarias.

Estas prácticas no son anecdóticas, sino estructurales. El enfoque de justicia reproductiva de Ross y Solinger (2017) (citados en Oliveira y Martínez, 2022), permite entender que las barreras en el acceso al aborto terapéutico no pueden analizarse en términos individuales, sino como resultado de sistemas que perpetúan desigualdades interseccionales. Las mujeres y personas gestantes más afectadas por estas barreras son aquellas con menores recursos, provenientes de zonas rurales, adolescentes o con condiciones de salud mental o discapacidad. La carga emocional, económica y física que implica acceder al procedimiento —como en el caso de Fernanda— pone en evidencia que, lejos de un servicio garantizado, el aborto terapéutico se convierte en un privilegio improbable, dependiente de redes informales y esfuerzos extraordinarios.

En línea con lo planteado por Amaya, Jiménez y Bermúdez (2023), el sesgo interseccional opera de manera sistemática en la atención médica. La evaluación del riesgo se realiza de manera desigual, y las decisiones clínicas se ven afectadas por prejuicios inconscientes relacionados con la edad, el nivel educativo y el origen rural de las usuarias.

En los establecimientos de primer nivel, la falta de capacitación y socialización del protocolo impide la detección temprana de casos que requieren derivación, mientras que en el segundo nivel, la respuesta clínica suele llegar tarde, comprometiendo la salud de las pacientes.

La Guía Nacional para la Aplicación del Aborto Terapéutico (2014) presenta restricciones que no consideran la realidad en la que viven la diversidad de usuarias en el Perú. Particularmente, la ubicación geográfica constituye una barrera significativa, pues las usuarias en zonas rurales o alejadas de centros urbanos enfrentan mayores dificultades para acceder a servicios especializados que solo se ofrecen en hospitales de nivel II. Estas usuarias deben recorrer largas distancias o enfrentarse a la ausencia total de profesionales capacitados en sus localidades.

Esta situación tiene múltiples consecuencias. En primer lugar, obstaculiza la prevención de embarazos riesgosos en pacientes con patologías previas. Además, impide la identificación temprana de condiciones fetales que hacen el producto inviable, ya que detectar malformaciones fetales requiere tecnología avanzada que no suele estar disponible en las postas médicas (nivel I). Estos factores constituyen una barrera de desigualdad para las

mujeres rurales, que se agrava al restringirse el servicio de aborto terepéutico a establecimiento de salud de nivel II.

El principio de justicia en salud exige no solo la eliminación de barreras físicas y administrativas, sino también el rediseño institucional desde la perspectiva de las usuarias. El enfoque de User Centered Design (UCD) ofrece una alternativa prometedora, al priorizar la experiencia y necesidades reales de las personas gestantes. Sin embargo, nuestros hallazgos evidencian que el sistema actual opera bajo una lógica inversa: son las usuarias quienes deben adaptarse a un entramado burocrático hostil, medicalizante y jerárquico. La falta de seguimiento post-aborto, particularmente en zonas rurales, refuerza esta desarticulación, dejando a las pacientes sin acompañamiento clínico, emocional ni logístico.

Finalmente, la exigencia de que las personas gestantes demuestren el riesgo para su salud —en lugar de que el Estado garantice el procedimiento como parte del derecho a la salud— constituye una inversión del principio de garantía. Aunque la norma penal no impone restricciones, su traducción en protocolos institucionales ha introducido requisitos adicionales —como el límite gestacional, la evaluación por una Junta Médica o la atención exclusiva en hospitales de Nivel II— que funcionan como filtros de acceso no contemplados originalmente por la ley. Esta lógica probatoria también se activa en la fase de identificación del riesgo, donde la persona gestante y, en muchos casos, su médico tratante deben argumentar ante una Junta que su estado de salud justifica el procedimiento. La falta de garantías legales para el personal médico, la fragmentación del sistema de salud y la escasa socialización del protocolo agravan esta dinámica, generando demoras, incertidumbre y decisiones clínicas condicionadas por el temor a consecuencias legales. En lugar de contar con un sistema que identifique y atienda de forma oportuna los casos legalmente viables, se espera que las usuarias —frecuentemente en situación de vulnerabilidad— transiten un proceso institucional que desconfía de su palabra y subordina su autonomía al juicio de instancias burocráticas. Así, la carga de la prueba no es solo un procedimiento técnico, sino una estrategia estructural de exclusión que vulnera el principio de equidad en salud, refuerza el control institucional sobre los cuerpos gestantes y perpetúa una lógica de criminalización encubierta, tal como lo advierten Bergallo (2018) y Halland et al. (2020). A través de esta inversión probatoria, el Estado traslada la responsabilidad de acceder a un derecho hacia quienes se encuentran en condiciones más vulnerables, despojando al aborto terapéutico de su carácter de bien público y esencial.

En suma, los hallazgos de este estudio permiten concluir que el acceso al aborto terapéutico en el Perú está profundamente condicionado por dinámicas de biopoder, discrecionalidad profesional, sesgos interseccionales y ausencia de una lógica centrada en las personas usuarias. Mientras no se reforme el diseño institucional y se garanticen condiciones estructurales que aseguren la atención oportuna, segura y libre de estigmas, este servicio seguirá siendo una excepción improbable, más que una garantía efectiva de salud y derechos.

6. Conclusiones

Los hallazgos de este estudio evidencian que el acceso al aborto terapéutico en el Perú, lejos de ser un servicio de salud efectivo y accesible, opera como un proceso altamente burocrático, restrictivo y sujeto a la discrecionalidad del personal médico. A pesar de que la normativa reconoce el derecho al aborto terapéutico, su implementación en hospitales como el Hospital Regional Docente de Cajamarca refleja una serie de barreras que obstaculizan su acceso real, especialmente para las mujeres y personas gestantes en situaciones de mayor vulnerabilidad.

Uno de los principales problemas identificados es que el diseño del servicio prioriza las necesidades del personal de salud sobre las de las usuarias. El procedimiento de aborto terapéutico está estructurado desde una lógica administrativa que impone requisitos innecesarios, como la convocatoria de una junta médica con múltiples especialistas, la firma de testigos y la validación de riesgos desde una perspectiva extremadamente restrictiva. Esto transforma un servicio de salud en un trámite que genera demoras críticas y, en algunos casos, pone en riesgo la vida de las usuarias.

Además, el servicio está centralizado en hospitales de nivel II, lo que implica que las usuarias deben recorrer largas distancias y superar múltiples filtros para acceder a la atención. En un contexto como Cajamarca, donde gran parte de la población reside en zonas rurales alejadas, esta centralización representa una barrera estructural que excluye a muchas personas del servicio. Una alternativa viable sería descentralizar el acceso al aborto terapéutico, permitiendo que el primer nivel de atención juegue un rol más activo en la orientación, derivación y evaluación de los casos.

Otro hallazgo relevante es la interpretación restrictiva del riesgo por parte del personal médico. Actualmente, el criterio predominante en la toma de decisiones es la inminencia de la muerte, lo que excluye a muchas pacientes con condiciones de salud preexistentes que ponen en riesgo su bienestar a largo plazo. Un servicio diseñado desde la perspectiva de las

usuarias debería incorporar un enfoque preventivo, reconociendo el impacto de la gestación en pacientes con patologías previas y riesgos para la salud mental.

Asimismo, la seguridad del personal de salud se ha convertido en una prioridad por encima de la atención oportuna de las usuarias. La criminalización del aborto ha generado una cultura de miedo entre los gineco-obstetras, quienes temen represalias legales y auditorías constantes. Este escenario ha llevado a la dilatación intencionada de los procedimientos y a la aplicación discrecional de la normativa. Para garantizar que el servicio funcione de manera adecuada, es imprescindible establecer protocolos claros y de cumplimiento obligatorio, evitando que la decisión quede sujeta a la interpretación personal de cada médico.

Finalmente, se identificó que ciertos grupos poblacionales, como niñas, adolescentes y personas con discapacidad, enfrentan barreras adicionales para acceder al aborto terapéutico. La falta de adecuaciones en los procedimientos, la ausencia de mecanismos de acompañamiento y el desconocimiento de los derechos de estos grupos limitan su acceso al servicio. Un sistema de salud verdaderamente inclusivo debe garantizar que estas poblaciones reciban atención diferenciada y adaptada a sus necesidades específicas.

Este estudio pone en evidencia la urgencia de una reforma en la implementación del aborto terapéutico en el Perú, de manera que el servicio deje de ser una estructura administrativa rígida y se transforme en un proceso accesible, oportuno y diseñado desde la perspectiva de las usuarias. Esto requiere cambios en la descentralización del servicio, la formación del personal médico en un enfoque preventivo de riesgos, la reducción de barreras burocráticas y la adopción de protocolos claros y obligatorios. Solo así se garantizará que el aborto terapéutico deje de ser un derecho inalcanzable para muchas personas y se convierta en un servicio de salud efectivo y humanizado.

7. Bibliografía

Arcos, C. (2018). Feminismos latinoamericanos: deseo, cuerpo y biopolítica de lo materno. Debate Feminista, (55), 27–58. https://doi.org/10.22201/cieg.01889478p.2018.55.02

Amaya,S., Jiménez, J. & C. Bermúdez. (2023). ¿Salud para quién? Interseccionalidad y sesgos de la inteligencia artificial para el diagnóstico clínico. *Anales del Sistema Sanitario de Navarra, 47*(2), 2-6. https://doi.org/10.23938/ASSN.1077

Bergallo, P. (2018). Del fracaso del giro procedimental a la inviabilidad del modelo de causales. En P. Bergallo, I. Jaramillo & M. Vaggione (Eds.), El aborto en América Latina. Estrategias jurídicas para luchar por su legalización y enfrentar las resistencias conservadoras (pp. 155–166). Siglo XXI Editores. https://www.redalas.net/repositorio/del-fracaso-del-giro-procedimental-la-inviabilidad-del-modelo-de-causales

Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades. (20 de febrero del 2025). *Sala Situacional de Muerte Materna y Morbilidad Materna Extrema.* https://app7.dge.gob.pe/maps/muerte_materna/#grafico01

Chang, A. & Brewer, G. (2023). Street-Level bureaucracy in public administration: A systematic literature review. *Public Management Review, 25,* 2191–2211. https://doi.org/10.1080/14719037.2022.2065517

Chiliquinga, K. & Erazo, D. (2023). La discrecionalidad como garantía al derecho a la salud pública en épocas de COVID. *LATAM Revista Latinoamericana De Ciencias Sociales Y Humanidades, 4*(5), 552–560. https://doi.org/10.56712/latam.v4i5.1337

Dopp, A. R., Parisi, K. E., Munson, S. A., et al. (2020). Aligning implementation and user-centered design strategies to enhance the impact of health services: Results from a concept mapping study. Implementation Science Communications, 1(17). https://doi.org/10.1186/s43058-020-00020-w

Erwin, K., & Krishnan, J. A. (2016). Redesigning healthcare to fit with people. BMJ, 354, i4536. https://doi.org/10.1136/bmj.i4536

Foucault, M. (1999). Nacimiento de la medicina social. En Obras esenciales (Vol. II, p. 366). Paidós.

Frías Urrea, R. (2013). Foucault y los orígenes griegos de la biopolítica. Revista de filosofía, 69, 119–132. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-43602013000100010

Granados, A. (2022). Interseccionalidad en salud, pobreza y vulnerabilidad. *Papeles de Población , 28*(111). https://doi.org/10.22185/24487147.2022.111.06

Haaland, M. E. S., Haukanes, H., Zulu, J. M., Moland, K. M., & Blystad, A. (2020). Silent politics and unknown numbers: Rural health bureaucrats and Zambian abortion policy. Social Science & Medicine, 251, 112909. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2020.112909

Melles, M., Albayrak, A., & Goossens, R. (2021). Innovating health care: Key characteristics of human-centered design. International Journal for Quality in Health Care, 33(Suppl_1), 37–44. https://doi.org/10.1093/intqhc/mzaa127

Ministerio de Salud del Perú. (2024, 22 de noviembre). Respuesta a la solicitud de acceso a la información pública sobre la cifra de médicos psiquiatras de los hospitales nivel II en todo el Perú de los años 2022, 2023 Y 2024.. Documento no publicado .

Ministerio de Salud del Perú. (2025, 10 de marzo). Respuesta a la solicitud de acceso a la información pública sobre muertes maternas indirectas según causa de defunción desde el 2014 al 2024. Documento no publicado.

Oliveira, T. & Martínez, A. (2022). Violencia gineco-obstétrica y justicia reproductiva. Una reflexión psicoantropológica. *Religación: Revista de Ciencias Sociales y Humanidades, 7*(34), 1-13. http://doi.org/10.46652/rgn.v7i34.990

Quintanas, A. (2011). Biopolítica y salud pública según M. Foucault. Estudios Filosóficos, 60, 435–451. https//estudiosfilosoficos.dominicos.org/ojs/article/download/1135/3430

Ramírez, S. (2022). Explorando las barreras para el acceso al aborto terapéutico en servicios de salud seleccionados de Puerto Maldonado-Tambopata-Madre de Dios-Perú [Tesis de maestría, FLACSO Argentina]. Repositorio FLACSO. https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/18528/5/TFLACSO-2022%20SIRZ%20vd.pdf

Sesia, P. (2020). Violencia obstétrica en México:La consolidación disputada de un nuevo paradigma en Violencia obstétrica en P. Quattrocchi & N. Magnone (Eds.), *América Latina conceptualización, experiencias, medición y estrategias* (pp. 3-29). Universidad Nacional de Lanús.

Sridhar, A., Koch, M. R., Kasliwal, A., et al. (2024). Beyond borders: The global impact of violating reproductive human rights. International Journal of Gynecology & Obstetrics, 167, 877–882. https://doi.org/10.1002/ijgo.15945